Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de São Luiz Gonzaga

Rua Coronel Fernando Machado, 2771 - Bairro: Centro - CEP: 97800000 - Fone: (55) 3352-4560 - Balcão Virtual: (55) 9 9653-4436 - Email: frsaoluiz1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001533-05.2024.8.21.0034/RS

AUTOR: MARIA CATARINA BRUM MOREIRA

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA / RS

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I- Relatório.

MARIA CATARINA BRUM MOREIRA propôs ação de obrigação de fazer em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA**, via de qual pede *"a procedência de todos os pedidos, inclusive o realizado em sede liminar"* (evento 1, INIC1).

Narra a inicial:

> *A autora é portadora de doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva, secundária a pneumonite de hipersensibilidade (CID J 68.0) e apresenta comprometimento pulmonar extenso (doença pulmonar intersticial com fibrose pulmonar progressiva).*
>
> *Diante do diagnóstico, necessita de tratamento de uso contínuo e por tempo indeterminado do medicamento NINTEDANIBE (OFEV), 150mg, na dosagem de um comprimido a cada 12h, totalizando duas cápsulas por dia (300mg) e sessenta por mês.*
>
> *De acordo com o teor do laudo médico anexo, a autora/paciente, encontra-se uso contínuo de terapia imunossupressora, atualmente em uso de Prednisolona 40mg/dia + Azatioprina 100mg/dia e totalmente afastada dos potenciais desencadeantes da patologia de base, contudo, apresentou piora em seu quadro clínico, com aumento da tosse e da falta de ar.*
>
> *Atualmente, possui dificuldades para realizar pequenas atividades do dia a dia. Diante do quadro de saúde da autora, o médico pneumologista, Dr. Carlos Henrique R. François, CREMERS 21081, RQE 12138, prescreveu o referido fármaco como tratamento adequado, o qual foi devidamente aprovado pela ANVISA no ano de 2020.*
>
> *Ocorre que, o medicamento em questão, embora imprescindível, não é disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS), consoante informação prestada pela Secretaria de Saúde do Município de São Luiz Gonzaga/RS.*

Deferida a gratuidade judiciária. Concedida a tutela antecipada (evento 3, DESPADEC1).

Citado, o Estado apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo. No mérito, afirmou que o SUS apresenta diversas terapias medicamentosas para o tratamento da patologia da autora. Aduziu que não houve a comprovação da imprescindibilidade e adequação do fármaco, tampouco da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS para o tratamento da moléstia descrita. Requereu a improcedência dos pedidos (evento 15, CONT1).

O Município apresentou contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que é o Estado quem deve cumprir com a obrigação gerada pela ordem judicial, porque na divisão administrativa das responsabilidades, esta obrigação, se imposta como foi pelo Judiciário, lhe cabe o cumprimento. Discorreu acerca da impossibilidade de fornecer o fármaco postulado. Requereu a improcedência dos pedidos (evento 19, CONT1).

Réplica (evento 25, RÉPLICA1).

Intimadas as partes acerca da produção de provas (evento 86, DESPADEC1).

Elaborada nota técnica pelo NATJUS (evento 188, NOTATEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II- Fundamentação.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Recentemente, com o julgamento dos Temas 1234 e 06, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, atinentes à disponibilização de medicamentos:

> *Súmula vinculante 60*
>
> *Enunciado*
>
> *O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)."*
>
> *Súmula vinculante 61*
>
> *Enunciado*
>
> *A concessão judicial de **medicamento** registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

De acordo com a tese fixada no Tema 1234 do STF, ficou determinado que:

> *"[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:*
>
> *(...)*
>
> *II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.*
>
> *(...)*
>
> *IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*
>
> *(...)*
>
> *VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão" [...]" (grifei).*

Por sua vez, o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou parâmetros para apreciação de pedidos de medicamentos não incorporados:

> *1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código*

de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.366.243/SC, o Min. Gilmar Mendes esclareceu:

Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).

Assim, nos termos do art. 987, §2º, do CPC, a tese jurídica fixada pelo STF tem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado. E os efeitos modulatórios da decisão, no caso, foram estabelecidos somente no que respeita à regra de competência.

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

Em análise objetiva, o medicamento postulado nesta ação possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não está incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do diagnóstico apresentado pela parte autora (evento 1, LAUDO8).

No presente feito, o laudo médico juntado atesta que a parte autora é portadora de Doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva, secundária a pneumonite de hipersensibilidade (CID J68.0) e necessita fazer uso do medicamento postulado. O médico assistente disse que não há medicação eficaz disponível no SUS (evento 1, LAUDO8).

Ainda, manifestou a urgência do tratamento para o caso:

Como a paciente apresenta doença pulmonar fibrosante progressiva e mostra sinais de piora clínica, radiológica e funcional na evolução de sua doença, mesmo em uso de terapia imunossupressora, solicitamos a medicação NINTEDANIBE (OFEV) 150mg na dose de 1 comprimido a cada 12 horas, 300 mg(2cp)/dia, 60 comprimidos/mês. O uso da medicação se dá em caráter de urgência, e deve ser usado continuamente, por período indeterminado.

Realizada nota técnica pelo NATJUS (evento 188, NOTATEC1), a qual foi favorável. Vejamos:

Conclusão

Tecnologia: ESILATO DE NINTEDANIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Com efeito, a parte demandante evidencia suficientemente a necessidade do medicamento através dos laudos médicos para comprovar a gravidade da sua enfermidade.

Além disso, demonstrada a carência de recursos para custear o tratamento.

Aliás, tudo em conformidade com a tese fixada Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça - REsp. 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo), que dispõe:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (Tema 106, do STJ - REsp. 1.657.156/RJ Recurso Repetitivo)

Desse modo, diante da comprovação da necessidade do medicamento, somada à ausência de recursos da parte autora em custeá-lo sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a procedência da demanda.

Por fim, tendo em vista que há pedido de bloqueio de valores por parte da autora (evento 263, PET1) e diante do julgamento de procedência dos pedidos e, por consequência, a ratificação da liminar concedida, tenho por deferir o pleito.

Na espécie, verifico que o orçamento mais módico apresentado no evento 263, OUT6, pela FARMÁCIA MB, tem o valor do medicamento orçado igual ou abaixo do preço máximo de venda ao governo, conforme tabela de consulta do PMVG, disponibilizada pela ANVISA . Confira-se:

SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	esilato de nintedanibe	150 MG CAP MOLE CT BL AL AL X 60	R$ 11.302,00
ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	esilato de nintedanibe	150 MG CAP MOLE CT BL AL AL X 60	R$ 11.302,02

Nesse sentido, deverá ser deferido o bloqueio de R$ 33.897,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais), das contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de São Luiz Gonzaga, no percentual de 50% a cada um.

Saliento, desde já, que os próximos pedidos de bloqueio de valores deverão ser propostos em sede de cumprimento de sentença.

III- Dispositivo.

Isso posto, **CONFIMO** a tutela de urgência concedida no evento 3, DESPADEC1 e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MARIA CATARINA BRUM MOREIRA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA** para determinar que os réus disponibilizem à autora o medicamento **NINTEDANIBE** 150 MG (OFEV), 60 comprimidos ao mês, cabendo a ela apresentar semestralmente a receita médica atualizada do referido insumo para seu fornecimento.

RATIFICANDO a liminar concedida, DEFIRO o bloqueio de R$ 33.897,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais), das contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de São Luiz Gonzaga, no percentual de 50% a cada um, para a aquisição do medicamento perante a FARMÁCIA MB (evento 263, OUT6), para o tratamento por um período de três meses, via sistema Sisbajud, pelo menor orçamento apresentado. A ordem já foi lançada e será oportunamente juntada aos autos.

Custas pelos demandados, ficando isentos da Taxa Única de Serviços Judiciais conforme a previsão do art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/14, mas respondendo por eventuais despesas do processo pendentes.

Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador da autora, os quais fixo em R$ 2.000,00, usando-se por analogia o art. 85, §8º, do CPC, já que o valor é alto e se trata de obrigação de fazer constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento objetivando a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens estes cujo valor é inestimável (STJ - AgInt no AREsp 1568584/SP).

Considerando a disciplina do CPC, que dispensa o Juiz do exame de admissibilidade da apelação interposta, havendo manejo de recurso, salvo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e, após, despicienda nova conclusão, remetam-se os autos ao eg. TJRS, com as homenagens e anotações de estilo.

Com o trânsito, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **NEIDER MOREIRA REIS JUNIOR, Juiz de Direito**, em 01/07/2025, às 18:28:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10085160630v8** e o código CRC **d3d564ff**.